

INDICADO POR: Dr. Claudio Frizon
MACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS 22222363048 | 985

MARCOS AURELIO SEGANTIN

IDADE: 65 PESO: 83 ALTURA: 1,81 PROFISSÃO: Aposentado / Comerciante

SINTOMAS:

QUEIXAS: Apnéias Presenciadas, Ronco, cansaço

MEDICAMENTOS: Bravato (HAS); Serozok (Anestesia)

MÉDICO: Dr. Claudio Frizon (Pneumo)

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: Bike 3x semana

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: 22h 22h30' HORA QUE ACORDA: 6h

COCHILHO (X) S () N DORME ACOMPANHADO: (X) S () N () EVENTUALMENTE *esporadicamente*

TEM FILHOS: (X) S () N / DORMEM NO QUARTO: () S (X) N PET NO QUARTO: () S (X) N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S (X) X NA SEMANA () N FSS social

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO:

BANHEIRO/NOITE:

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP:

MALLAMPATI:

IAH: 47,8elh SPO2: 81%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: 0

CIRURGIAS: (N) NASAL (S) AMIGDALECTOMIA *ciompa*

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: 0 *pneumonia jun/2024*

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA

(N) NEUROLÓGICA

() OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S (X) N

SPO2 C/ CPAP:

PRESSÃO NO EXAME:

05/02/2025 - Avaliação Auto 4 à 10 cmH₂O Dream wear (L)

13/02/25 P=8,0 med. Deixo (4-8 cmH₂O) Silêncio
IAH=6,6
m. de uso: 7h23' *boa*

27/02 25 P=8,2 cmH₂O - Estar c/ a mãe na UTI.
IAH=4,8
m. de uso: 6h35' -
fuga=0,3 e ltr *boa clínicamente*

30/03/25 P=8,2 cmH₂O Pressão fixa 8,2 cmH₂O
IAH=4,7elh
m. de uso: 6h19
fuga=32 l/min *humidif. 4 ramp 4 cmH₂O 5min*

05/03/25. P= 6-8,2 cm H₂O
IAH= 4,8 e/h
mdi uso: 4h 51'
fuga: 10,1 l/m

fixo P= 8,2 cm H₂O
Relata estar dormindo
Bem

02/07/25 P= 8,2 cm H₂O
FAH= 1,9 e/h
M. de uso: 3h 31'
fuga= 16 lpm.

Natacha

- Vigia tr leveu
 - Acoberso sobre 4 N^o horas.
- para claudia

Nome: MARCOS AURELIO SEGATIN

Data de Nascimento: 26-4-1959

IMC: 25,03

Sexo: Masculino

Data do exame: 27-11-2024

Peso: 82 kg

Altura: 1,81 m

Médico: DR. CLAUDIO RICARDO FRISON

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 27-11-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 532,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 6,5 e 182,0 minutos. O tempo total de sono foi de 496,0 min, eficiência de 93,1% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,7%; estágio N2: 69,9%; estágio N3: 12,9%; sono REM: 15,5%. O índice de despertares foi de 33,6/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 47,8/hora, sendo 59 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 266 hipopnéias. A SpO2 média foi de 94% e a mínima de 81%, permanecendo 2,8% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 52 - 110 bpm e NREM de 39 - 122 bpm.

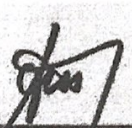
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (6), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 47,8/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=81%);
5. latência para o sono REM aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono